

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	椎間盤突出 Herniated Intervertebral Disc；HIVD				
編號	A31000-Q03-W-A06	制定者	R12 林碧嵐	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	112 年 09 月 05 日
版本/總頁數	第 3.9 版/7 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解椎間盤突出的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

當椎間盤的壁變薄，使得部分膠樣之髓核向外突出，穿過此韌帶進入脊椎管壓迫至神經根。此一病變就叫椎間盤突出。

（二）症狀

1. 先有下背痛，然後在臀部、大腿後外側、小腿外側到足部。
2. 因噴嚏、咳嗽、彎腰加劇。
3. 躺下舒服、疼痛輻射至腿足。
4. 小腿、大腿後側有抽搐痛。
5. 深部肌腱反射減弱。
6. 坐骨神經痛。
7. 站立時骨盆傾斜。
8. 坐骨神經上深部觸診會感壓痛。

（三）常見檢查

1. 腰椎 X 光片。

主題名稱	椎間盤突出	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	2/7

2. 磁振造影(Magnetic Resonance Image；MRI)。

3. 電腦斷層。

(四) 常見治療

1. 保守治療

目的是藉著減少患部承受正常負重的活動所形成的壓力，來緩解疼痛。治療方法包括臥床休息、骨盆帶牽引、以深熱敷和特殊運動做物理治療等。急性肌肉痙攣的病人，可採用冰敷按摩，可能需要給予鎮靜劑以緩解疼痛，通常是給予肌肉鬆弛劑。

2. 物理治療

除了使用藥物外還可以配合深部超音波熱療法與局部熱敷來緩解疼痛、鬆弛肌肉。教導病人適當的運動訓練背部肌肉，如仰臥起坐，將骨盆抬高及膝胸運動等。

3. 手術治療

當病人對保守療法無改善或是神經功能障礙日趨嚴重造成運動或感覺麻痺、括約肌控制能力喪失、垂足、疼痛嚴重，影響到病人之日常生活以及工作時，則必須採用手術治療來緩解病況。

(1) 椎盤切除術：醫師會在椎間盤突出處切開，然後將突出的椎間盤與有關的組織切除。

(2) 內視鏡下施行椎間盤切除術：可從螢幕監視下直接到達病灶，僅僅去除突出的椎間盤組織，而不會減少或影響中央髓核組織。

(3) 椎板切除術：切除椎板，以露出在脊髓管內的神經內容物，藉以檢視脊椎管，辨別並切除脊髓、神經根的病理組織與所受到的壓力。

(4) 椎板切除術併行融合術：用骨移植來融合脊椎的棘突或內固定，目的是要架橋在缺損的椎盤上，以穩定脊椎。

(五) 護理問題

1. 疼痛不適／組織創傷如：手術。

主題名稱	椎間盤突出	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	3/7

2. 易跌倒／手術後。

(六) 護理措施

1. 疼痛不適／組織創傷如：手術

- (1) 評估病人的疼痛程度及特徵。
- (2) 評估疼痛加劇的原因。
- (3) 減少或排除疼痛的因素。
- (4) 教導利用枕頭或毛毯支持疼痛部位。
- (5) 教導放鬆技巧，如：深呼吸、背部按摩、冥想。
- (6) 予轉移注意力，如：音樂、書籍、聊天。
- (7) 依醫囑予物理治療，如：熱敷、冰敷。
- (8) 在病人選擇疼痛控制方法時，給予支持與指導。
- (9) 教導咳嗽或改變姿勢時，以手或束腹帶固定傷口。
- (10) 與病人及家屬共同討論可控制引發疼痛因素之方法。
- (11) 避免腹部用力，如：哭鬧蹲姿、用力解便、咳嗽，預防傷口疼痛或裂開。
- (12) 依醫囑給予止痛劑。
- (13) 評值疼痛控制技巧的效果。
- (14) 評估藥物的效果及副作用。
- (15) 衛教病人咳嗽時可按壓傷口，避免牽扯疼痛。
- (16) 鼓勵家屬多予陪伴。

2. 易跌倒／手術後。

- (1) 病人臥床時使用床欄並注意床欄穩固。
- (2) 降低病床高度。
- (3) 使用夜燈。
- (4) 使用防滑墊、穿著止滑鞋。
- (5) 清除病床到浴室間的障礙物，保持地面乾燥及適當照明。
- (6) 護理人員每班至少兩小時查看病人情形。

主題名稱	椎間盤突出	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	4/7

- (7) 將尿壺或便盆置於可拿取位置。
- (8) 讓病人及家屬瞭解目前活動能力及限制，應採漸進式活動，且有人在旁扶助。
- (9) 教導病人使用叫人鈴並置於病人隨手可得之處。
- (10) 讓病人及家屬瞭解正在服用易導致跌倒的藥物，如降壓藥、鎮靜安眠藥、抗癲癇藥、止痛麻醉藥、抗憂鬱藥、肌肉鬆弛劑、抗精神病藥、降血糖藥、軟便劑、利尿劑、輕瀉劑…等。
- (11) 衛教病人在服用藥物後半小時內改變姿勢宜緩慢，應注意服藥後副作用，視藥物特性給予個別性衛教，並建議服藥後減少下床，若下床應注意活動安全。
- (12) 必要時依醫囑給予適當的約束。
- (13) 依照顧者國籍給予預防跌倒照護單張。

(七) 衛教指導

1. 預防跌倒須知。
2. 脊椎手術照護。
3. 如何緩解急性疼痛。
4. 術後一般傷口照護。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	椎間盤突出	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	5/7

六、參考資料

- (一) 馮容芬譯(2020)・神經系統疾病之護理・成人內外科護理(下冊, 76-89)・台北：偉華。
- (二) 曾詩雯等譯(2021)・NANDA International 護理診斷：定義與分類 2021-2023・台北：華杏。
- (三) 林佩怡(2020)・A Study of Patients with Postoperative Cervical Disc Herniation on Medical Quality・義守大學醫務管理學系學位論文。
- (四) 劉哲瑋(2022)・進步的內視鏡脊椎融合手術・健康世界, (552), 38-39。

七、附件

(略)

主題名稱	椎間盤突出	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改常見治療內容的修辭	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31.	2.2	1.修改衛教單張名稱:脊椎保健改脊椎手術照護 2.醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.08.31.	3.1	常見檢查內容新增：電腦斷層	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	3.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.2	說明內容手術治療部分修辭潤飾	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31.	3.3	將年限較久參考文獻刪除並增加近期參考文獻	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.4	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 新增第三項第(七)目之 3 相關衛教指導。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.5	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過

主題名稱	椎間盤突出	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A06	版本	第 3.9 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
108.09.23	3.6	1. 第三項第五目、第六目之 2 修改護理問題、護理措施內容。。 2. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.09.07	3.7	第三項第六目之 2(9)~(11)說明內容新增修訂。	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過；110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	3.8	1. 第三項第五目、第六目護理問題及護理措施內容部份修辭潤飾。 2. 第六項參考資料文獻部份內容更新。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過；111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.9	第六項參考資料文獻部份內容更新。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過；112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.08.07	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	